



PARADISE · INCLUSIE

Wie komt in **aanmerking**?

Alle zes moeten kloppen. Onthoud **VOETEN**.

V**Vaten stabiel**

stabiele vaatstatus, PEDIS-graad 1–2, naar oordeel van de behandelende arts

O**Onlangs een voetwonde**

IWGD-risico 3, met 2 weken tot 18 maanden geleden een genezen plantair ulcus, een teen- of halluxamputatie, of een resectie van één of meer metatarsaalkopjes (ook de eerste)

E**Eigen stappen**

stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel

T**Type 1 of 2**

diabetes mellitus type 1 of 2; geen zwangerschapsdiabetes

E**Echt beschermend schoeisel**

volledig op maat, of maatzen in semi-orthopedisch schoeisel, of maatzen in confectie met extra diepte; of bereid om over te schakelen

N**Nederlands en volwassen**

18 jaar of ouder, begrijpt Nederlands

TWIJFEL OVER EEN PATIËNT?

Vraag het studieteam: paradise-tbm@kuleuven.be

ommezijde: wie niet →



PARADISE · INCLUSIE

Wie komt in **aanmerking**?

Alle zes moeten kloppen. Onthoud **VOETEN**.

V**Vaten stabiel**

stabiele vaatstatus, PEDIS-graad 1–2, naar oordeel van de behandelende arts

O**Onlangs een voetwonde**

IWGD-risico 3, met 2 weken tot 18 maanden geleden een genezen plantair ulcus, een teen- of halluxamputatie, of een resectie van één of meer metatarsaalkopjes (ook de eerste)

E**Eigen stappen**

stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel

T**Type 1 of 2**

diabetes mellitus type 1 of 2; geen zwangerschapsdiabetes

E**Echt beschermend schoeisel**

volledig op maat, of maatzen in semi-orthopedisch schoeisel, of maatzen in confectie met extra diepte; of bereid om over te schakelen

N**Nederlands en volwassen**

18 jaar of ouder, begrijpt Nederlands

TWIJFEL OVER EEN PATIËNT?

Vraag het studieteam: paradise-tbm@kuleuven.be

ommezijde: wie niet →



PARADISE · INCLUSIE

Wie komt in **aanmerking**?

Alle zes moeten kloppen. Onthoud **VOETEN**.

V**Vaten stabiel**

stabiele vaatstatus, PEDIS-graad 1–2, naar oordeel van de behandelende arts

O**Onlangs een voetwonde**

IWGD-risico 3, met 2 weken tot 18 maanden geleden een genezen plantair ulcus, een teen- of halluxamputatie, of een resectie van één of meer metatarsaalkopjes (ook de eerste)

E**Eigen stappen**

stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel

T**Type 1 of 2**

diabetes mellitus type 1 of 2; geen zwangerschapsdiabetes

E**Echt beschermend schoeisel**

volledig op maat, of maatzen in semi-orthopedisch schoeisel, of maatzen in confectie met extra diepte; of bereid om over te schakelen

N**Nederlands en volwassen**

18 jaar of ouder, begrijpt Nederlands

TWIJFEL OVER EEN PATIËNT?

Vraag het studieteam: paradise-tbm@kuleuven.be

ommezijde: wie niet →



PARADISE · INCLUSIE

Wie komt in **aanmerking**?

Alle zes moeten kloppen. Onthoud **VOETEN**.

V**Vaten stabiel**

stabiele vaatstatus, PEDIS-graad 1–2, naar oordeel van de behandelende arts

O**Onlangs een voetwonde**

IWGD-risico 3, met 2 weken tot 18 maanden geleden een genezen plantair ulcus, een teen- of halluxamputatie, of een resectie van één of meer metatarsaalkopjes (ook de eerste)

E**Eigen stappen**

stapt zelfstandig blootsvoets, zonder hulpmiddel

T**Type 1 of 2**

diabetes mellitus type 1 of 2; geen zwangerschapsdiabetes

E**Echt beschermend schoeisel**

volledig op maat, of maatzen in semi-orthopedisch schoeisel, of maatzen in confectie met extra diepte; of bereid om over te schakelen

N**Nederlands en volwassen**

18 jaar of ouder, begrijpt Nederlands

TWIJFEL OVER EEN PATIËNT?

Vraag het studieteam: paradise-tbm@kuleuven.be

ommezijde: wie niet →

Eén criterium volstaat om uit te sluiten.

- ✗ Amputatie proximaal van de MTP-gewrichten
- ✗ Actief voetulcus of Charcot-deformiteit
- ✗ Kritische ischemie, PEDIS 3: enkeldruk < 50, teendruk < 30 of $TcpO_2$ < 30 mmHg
- ✗ Nierfunctievervangende therapie
- ✗ Immunosuppressieve therapie
- ✗ Verwachte overleving < 18 maanden, naar oordeel van de arts
- ✗ Kan geen toestemming geven of de instructies niet volgen
- ✗ Hulpmiddel dat de druksensoren belemmert, zoals een enkelvoetorthese
- ✗ Weigert het beschermend schoeisel of de draagsensor in de zool

De arts screent en vraagt de toestemming; de PI loot na bevestigde geschiktheid.
Bron: studieprotocol §4.1 · IWGDF 2023

Eén criterium volstaat om uit te sluiten.

- ✗ Amputatie proximaal van de MTP-gewrichten
- ✗ Actief voetulcus of Charcot-deformiteit
- ✗ Kritische ischemie, PEDIS 3: enkeldruk < 50, teendruk < 30 of $TcpO_2$ < 30 mmHg
- ✗ Nierfunctievervangende therapie
- ✗ Immunosuppressieve therapie
- ✗ Verwachte overleving < 18 maanden, naar oordeel van de arts
- ✗ Kan geen toestemming geven of de instructies niet volgen
- ✗ Hulpmiddel dat de druksensoren belemmert, zoals een enkelvoetorthese
- ✗ Weigert het beschermend schoeisel of de draagsensor in de zool

De arts screent en vraagt de toestemming; de PI loot na bevestigde geschiktheid.
Bron: studieprotocol §4.1 · IWGDF 2023

Eén criterium volstaat om uit te sluiten.

- ✗ Amputatie proximaal van de MTP-gewrichten
- ✗ Actief voetulcus of Charcot-deformiteit
- ✗ Kritische ischemie, PEDIS 3: enkeldruk < 50, teendruk < 30 of $TcpO_2$ < 30 mmHg
- ✗ Nierfunctievervangende therapie
- ✗ Immunosuppressieve therapie
- ✗ Verwachte overleving < 18 maanden, naar oordeel van de arts
- ✗ Kan geen toestemming geven of de instructies niet volgen
- ✗ Hulpmiddel dat de druksensoren belemmert, zoals een enkelvoetorthese
- ✗ Weigert het beschermend schoeisel of de draagsensor in de zool

De arts screent en vraagt de toestemming; de PI loot na bevestigde geschiktheid.
Bron: studieprotocol §4.1 · IWGDF 2023

Eén criterium volstaat om uit te sluiten.

- ✗ Amputatie proximaal van de MTP-gewrichten
- ✗ Actief voetulcus of Charcot-deformiteit
- ✗ Kritische ischemie, PEDIS 3: enkeldruk < 50, teendruk < 30 of $TcpO_2$ < 30 mmHg
- ✗ Nierfunctievervangende therapie
- ✗ Immunosuppressieve therapie
- ✗ Verwachte overleving < 18 maanden, naar oordeel van de arts
- ✗ Kan geen toestemming geven of de instructies niet volgen
- ✗ Hulpmiddel dat de druksensoren belemmert, zoals een enkelvoetorthese
- ✗ Weigert het beschermend schoeisel of de draagsensor in de zool

De arts screent en vraagt de toestemming; de PI loot na bevestigde geschiktheid.
Bron: studieprotocol §4.1 · IWGDF 2023